

SOAL UJIAN OSCE
STATION : Neuroanestesi

1.	Nomor Station	4A
2.	Judul Station	Cerebral salt wasting syndrome – pemasangan CVC
3.	Alokasi Waktu	17 menit
4.	Tujuan Station	Menilai kemampuan mengenali masalah pascaoperasi kraniotomi, dan kemampuan penatalaksanaan pascaoperasi kraniotomi Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
5.	Kompetensi Diujikan	1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i> 2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis 4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) 5. Kemampuan Monitoring 6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7.	Instruksi Peserta Ujian	<u>Skenario Klinik:</u> Seorang perempuan berusia 45 tahun, berat badan 60 kg, dirawat di ICU pascaoperasi hari ke-2 kraniotomi evakuasi hematoma. Pada hari ke-3 perawatan di ICU, didapatkan kesadaran menurun, produksi urin mencapai 10.000 cc dalam 24 jam, pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, laju nadi 120x/menit, SpO2 99% lain-lain dalam batas normal, pasien masih tersambung ventilasi mekanik. <u>Instruksi Peserta :</u> 1. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang dan interpretasinya dan hitung osmolaritas serum pasien. 2. Sebutkan kemungkinan diagnosis klinis dan diagnosis banding pasien ini. 3. Lakukan pemasangan CVC subclavia pada pasien ini 4. Sebutkan tatalaksana pasca operasi kraniotomi pada pasien ini.

8.	Instruksi Penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/ hasil yang dibutuhkan secara lisan/ tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/ atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji menjawab hasil pemeriksaan penunjang (hanya jika diminta oleh peserta!) dan menilai interpretasi yang dilakukan oleh peserta uji! Pemeriksaan Penunjang: pemeriksaan serum : elektrolit, BUN, GDS; pemeriksaan urine tampung 24 jam : berat jenis, elektrolit urine 1. Darah rutin : Hb 12 gr/dl, Leukosit 11.000 mm³/L, Ht 42 %, Trombosit 120.000 mm³/L Interpretasi : dalam batas normal 2. Elektrolit darah : Natrium 120 mEq/L, Kalium 3,1 mEq/L, Klorida 97 mEq/L, Interpretasi : hyponatremia hipokalemia 3. Fungsi ginjal BUN 28 gr/dl, kreatinin 1,2 mg/dl Interpretasi: dalam batas normal 4. Gula Darah Sewaktu 180 gr/dl Interpretasi: dalam batas normal 5. Urine tampung 24 jam : Berat jenis 1,050 (N : 1,006-1,022) Natrium 120 (N : 100.6-102.8) Peserta diberikan kalkulator untuk menghitung jumlah produksi urine, dan osmolaritas serum
----	-------------------	---

		Produksi urin : 6,9 cc/kg/jam 6. Osmolaritas serum : 260 mOsm/L Interpretasi : Hiponatremia dengan hipoosmolar dan peningkatan osmolaritas urine 2 Penguji menilai diagnosis klinis Diagnosis Klinis : 1. Cerebral salt wasting syndrome Diagnosis banding 1. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH) 2. Hypovolemic 3. Poliurie
--	--	---

		3. Penguji menilai kemampuan peserta dalam melakukan tindakan pemasangan CVC <i>subclavia</i> secara benar dan runut. Pemasangan CVC <i>subclavia</i>: 1) Melakukan <i>informed consent</i>. 2) Melakukan persiapan alat dan obat. 3) Memastikan monitor terpasang dengan baik. 4) Memposisikan pasien. 5) Mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril. 6) Mengidentifikasi lokasi penusukan berdasarkan landmark anatomi. 7) Melakukan sterilisasi daerah yang sudah teridentifikasi. 8) Memasang duk steril berlubang pada daerah yang sudah diidentifikasi. 9) Melakukan infiltrasi anestesi lokal (lidokain) pada kulit daerah pemasangan CVC. 10) Menusukkan jarum CVC pada lokasi yang sesuai dengan arah yang tepat. 11) Melakukan aspirasi darah. 12) Melakukan pemasangan <i>guidewire</i> sambil memperhatikan irama jantung di monitor. 13) Mencabut jarum CVC sambil memastikan <i>guidewire</i> tetap berada di posisinya. 14) Memasukkan dilator dan mencabutnya kembali. 15) Memasang kateter CVC melalui <i>guidewire</i> sampai kedalaman yang telah ditentukan. 16) Melakukan aspirasi pada semua lumen. 17) Memfiksasi kateter CVC dengan menjahitnya ke kulit. 18) Menutup dengan kassa steril. 19) Mencuci tangan. 20) Melakukan pemeriksaan foto toraks. 4 Penguji menilai kemampuan peserta menentukan tatalaksana dan monitoring evaluasi pascaoperasi kraniotomi pada pasien ini. Tatalaksana: 1. Penggantian cairan isotonis 2. Target koreksi Na perlahan ≤ 1.5 mEq/l/jam 3. Target penggantian cairan : balans cairan seimbang 4. Target balans seimbang bertahap dalam 24 jam mendatang 5. Target serum Na pada 24 jam mendatang >130 5. Penguji menilai komunikasi, edukasi serta perilaku profesionalisme peserta.
9.	Tata letak station	Setting ruang ICU
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Membantu pemasangan CVC
11	Peralatan Yang Dibutuhkan	Setting Ruang ICU – CVC fr 7 set – Cadangan wire CVC – S spuit 3 cc, 5 cc, 10 cc – Cairan, Infus set, tiang infus

		- Nacl 0,9 atau water untuk pemasangan - Lidocain 2 % - Benang silk 3,0 - Povidone iodine - Alkohol - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 - Topi operasi dan masker 2 Set pemasangan CVC - Nampan alat - Kain steril lubang - Cawan dengan label povidone iodine, alcohol, nacl 0,9 - Gaun steril - Kassa - Pinset - Needle holder - Gunting benang - Manometer Kalkulator Manekin cvc
12	Kebutuhan Manekin	Manekin CVC
13	Penulis	TIM SOAL OSCE ATI
14	Referensi	1.Morgan 2. Leonard J, Garrett RE, Salottolo K, Slone DS, Mains CW, Carrick MM, Bar-Or D. Cerebral salt wasting after traumatic brain injury: a review of the literature. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2015 Nov 11;23:98. doi: 10.1186/s13049-015-0180-5. PMID: 26561391; PMCID: PMC4642664. 3. Tenny S, Thorell W. Cerebral Salt Wasting Syndrome. [Updated 2023 Aug 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534855/ 4. Pedoman tatalaksana medis ICU, JCCA 2018

--	--	--

RUBRIK ACTUAL MARK
SOAL UJIAN OSCE STATION : Neuroanestesi

I. Rubrik

ASPEK YANG DINILAI	0	1	2	3	BOBOT	SKOR
1. Kemampuan menentukan pemeriksaan penunjang dan interpretasi pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis Pemeriksaan yang dilakukan 1. Darah rutin 2. Serum elektrolit 3. Serum BUN, Cr, 4. GDS 5. Urine tampung 6. Osmolaritas darah	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang selain yang telah ditetapkan	Peserta ujian hanya dapat mengusulkan1-2 pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi denganbenar yang Didalamnya Termasuk penghitungan Osmolaritas darah	Peserta ujian hanya dapat mengusulkan3-4 pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi denganbenar yang Didalamnya Termasuk penghitungan Osmolaritas darah	Peserta ujian mengusulkan semua pemeriksaan penunjang dengan tepat dan dapat memberikan interpretasi denganbenar.	2	

3. Kemampuan mengenali permasalahan pascaoperasi kraniotomi Diagnosis Klinis 1. Cerebral salt wasting syndrome Diagnosis banding 1. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH) 2. Hypovolemic 3. Poliurie	Peserta ujian tidak dapat menyampaikan diagnosis dengan tepat dan tidak dapat menyebutkan diagnosis banding	-	Peserta ujian dapat menyampaikan diagnosis klinis dengan lengkap saja, Atau dapat menyebutkan minimal 1 diagnosis banding saja	Peserta ujian dapat menyampaikan diagnosis klinis dengan lengkap, dan dapat menyebutkan minimal 1 diagnosis banding	1	
3. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit Pemasangan CVC <i>subclavia</i> : 1) Melakukan <i>informed consent</i> . 2) Melakukan persiapan alat dan obat. 3) Memastikan monitor terpasang dengan baik. 4) Memposisikan pasien. 5) Mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril. 6) Mengidentifikasi lokasi penusukan berdasarkan landmark anatomi. 7) Melakukan sterilisasi daerah yang sudah teridentifikasi. 8) Memasang duk steril berlubang pada daerah yang sudah diidentifikasi. 9) Melakukan infiltrasi anestesi lokal (lidokain) pada kulit daerah pemasangan CVC. 10) Menusukkan jarum CVC pada lokasi yang sesuai dengan arah yang tepat. 11) Melakukan aspirasi darah.	Peserta tidak melakukan pemasangan CVC.	Peserta ujian tidak berhasil melakukan pemasangan CVC.	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemasangan CVC Namun tidak runut.	Peserta ujian melakukan semua tahapan pemasangan CVC benar dan runut.	3	

12) Melakukan pemasangan <i>guidewire</i> sambil memperhatikan irama jantung di monitor. 13) Mencabut jarum CVC sambil memastikan <i>guidewire</i> tetap berada di posisinya. 14) Memasukkan dilator dan mencabutnya kembali. 15) Memasang kateter CVC melalui <i>guidewire</i> sampai kedalaman yang telah ditentukan. 16) Melakukan aspirasi pada semua lumen. 17) Memfiksasi kateter CVC dengan menjahitnya ke kulit. 18) Menutup dengan kassa steril. 19) Mencuci tangan. 20) Melakukan pemeriksaan foto toraks						
---	--	--	--	--	--	--

4. Kemampuan monitoring Tatalaksana: 1. Penggantian cairan isotonis 2. Target koreksi Na perlahan ≤ 1.5 mEq/l/jam 3. Target penggantian cairan : balans cairan seimbang 4. Target balans seimbang bertahap dalam 24 jam mendatang 5. Target serum Na pada 24 jam mendatang >130 •	Peserta ujian tidak dapat melakukan tata laksana pada pasien	Peserta menyebutkan 1-2 tatalaksana, monitoring dan evaluasi pada pasien	Peserta menyebutkan 3-4 tatalaksana, monitoring dan evaluasi pada pasien	Peserta menyebutkan semua tatalaksana, monitoring dan evaluasi pada pasien	3	
---	--	--	--	--	---	--

5. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan Meminta izin secara lisan dan melakukan poin komunikasi, edukasi, profesionalisme.	Meminta izin secara lisan dan melakukan poin komunikasi, edukasi, profesionalisme minimal 1 poin dari 5 poin yang ada.	Meminta izin secara lisan dan melakukan poin komunikasi, edukasi, profesionalisme 3 poin dari 5 yang ada	Meminta izin secara lisan dan melakukan poin komunikasi, edukasi, profesionalisme secara lengkap.	1	
---	---	---	---	--	---	--

